Maladie professionnelle : l'IRM de l'épaule n'est plus exigée par le tableau 57

La rédaction du Cercle des Généralistes · 10 novembre 2026 · 9 min de lecture

SITUATION

Certificats de maladie professionnelle établis depuis le 30 septembre 2026 : 41 tableaux réécrits, IRM, EFR et d'autres examens retirés de plusieurs.

Les décrets n° 2026-900 et n° 2026-901 du 24 septembre 2026, parus au Journal officiel n° 227 du 29 septembre 2026, appliquent l'article 95 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2026. Le décret n° 2026-901 fixe l'entrée en vigueur au 30 septembre 2026, pour les procédures dont le certificat médical initial est établi à compter de cette date. Sont concernés les généralistes et les autres médecins qui rédigent ce certificat, et leurs patients.

L'ESSENTIEL

- **Ce qui change :** plusieurs des 41 tableaux modifiés n'imposent plus certains examens ; un examen n'est attendu que s'il est nécessaire au diagnostic et conforme aux recommandations.
- **Quand :** pour tout certificat médical initial établi à compter du 30 septembre 2026.
- **Que faire :** rédiger le certificat dès que l'origine professionnelle est possible, sans attendre un examen, et décrire précisément les pathologies observées.

CONTEXTE

Au 1er novembre 2026, la FMF écrit : « nous n'avons vu passer strictement aucune communication de l'UNCAM ni du Ministère de la Santé ». La page de l'Assurance Maladie destinée aux médecins, datée du 2 novembre 2026, ne mentionne pas ces décrets.

CE QUI EST CONFIRMÉ

Sur le principe, le décret n° 2026-900 modifie les articles R. 461-9 et R. 743-3-2 du code de la sécurité sociale. Les examens « le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles » deviennent des examens requis « lorsqu'ils sont nécessaires pour établir le diagnostic de la maladie » et « conformes aux données acquises de la science au regard des recommandations de bonnes pratiques de la Haute Autorité de santé ou des sociétés savantes ».

Sur les tableaux, l'article 2 du décret n° 2026-901 modifie 41 tableaux. Dans le tableau n° 57, il supprime notamment « objectivée par IRM (*) », « confirmé par électroneuromyographie (EMG) » et « objectivée par échographie ». Dans le tableau n° 30, il supprime les confirmations par examen tomodensitométrique. Dans le tableau n° 79, il supprime « , confirmées par IRM (*) ou au cours d'une intervention chirurgicale ». Dans de nombreux tableaux, il retire le mot « épicutané » et les mots « objectivé par explorations fonctionnelles respiratoires ». Dans 11 de ces 41 tableaux (n° 2, 8, 10,

31, 37, 38, 49, 51, 65, 84 et 95), la suppression du mot « épicutané » est la seule modification : le test reste mentionné, sans précision de type.

Sur ce qui reste, le tableau n° 90 maintient une bronchopneumopathie caractérisée par un VEMS « abaissé d'au moins 40 % par rapport à la valeur moyenne théorique ». Selon la FMF, « les conditions de validation des MP ne changent pas » : liste limitative des pathologies, délais et activités à risque. Le II de l'article 95 de la loi fixait au plus tard au 30 septembre 2026 l'entrée en vigueur du 1° de son I ; les décrets ont paru la veille. Le même II fixe au plus tard au 1er janvier 2027 l'entrée en vigueur des 2°, 3° et 5°, dont nous n'avons pas pu lire le détail.

Côté Assurance Maladie, la page du 2 novembre 2026 rappelle qu'il n'est pas obligatoire de préciser le tableau dans le certificat médical initial. Elle indique aussi que des examens complémentaires « peuvent être réclamés par la caisse d'assurance maladie pour confirmer le diagnostic de la maladie » et que « Certains de ces examens sont expressément prévus par des tableaux. » Elle propose toujours une « Liste des examens médicaux à effectuer en cas de maladie professionnelle (version médecin) ». Le document obtenu par ce lien, relu le 10 novembre 2026, n'a pas de date et porte en en-tête « Version patient ». Il indique encore pour le tableau n° 57 une tendinopathie « objectivée par IRM », avec comme examen prévu « IRM de l'épaule, arthroscanner en cas de contre indication », et un électroneuromyogramme pour le nerf ulnaire au coude.

CE QUI POSE QUESTION

Au 10 novembre 2026, 5 questions restent ouvertes.

La suppression est-elle réelle ? Les décrets retirent la mention de l'examen, pas la description de la maladie. Selon la FMF, le tableau n° 57 vise toujours une tendinopathie non rompue non calcifiante, et « une échographie sera tout aussi pertinente pour la mettre en évidence », alors que le décret retire aussi la mention « objectivée par échographie ». L'examen peut donc rester nécessaire en pratique, là où il n'est plus exigé en droit.

Qui tranche si la caisse réclame un examen ? Les 2 décrets ne désignent pas qui apprécie la nécessité, mais la page de l'Assurance Maladie du 2 novembre 2026 indique que des examens « peuvent être réclamés par la caisse d'assurance maladie » et que la décision sur le lien professionnel relève exclusivement d'elle. Les décrets renvoient à la Haute Autorité de santé ou aux sociétés savantes, sans liste. La FMF écrit qu' « on peut penser » que, s'il existe une recommandation, « elle s'impose aux médecins traitants et aux médecins-conseil, sinon il faudra probablement échanger ». Sans recommandation, le dossier dépendrait donc d'un échange avec le médecin-conseil. Le texte modifié de l'article L. 461-1 n'a pas pu être lu.

Quand démarre le délai d'instruction ? Le décret n° 2026-900 fait courir le délai à partir du moment où le médecin-conseil dispose du résultat des examens, « lorsqu'ils sont nécessaires ». L'enjeu est concret : selon l'Assurance Maladie, la caisse dispose de 120 jours et l'absence de réponse dans le délai réglementaire vaut reconnaissance de la maladie professionnelle. Si la caisse juge après coup qu'un examen manquait, rien dans les textes lus ne dit si le délai repart. À l'inverse, si l'examen n'était pas nécessaire, on peut soutenir que le délai a couru dès le dossier complet, avec reconnaissance à défaut de réponse : c'est notre lecture, sans garantie.

Les tableaux absents du décret gardent-ils leurs examens ? Le décret n° 2026-900 remplace la référence générale aux examens prévus par les tableaux, alors que le décret n° 2026-901 ne les retire que de 41 tableaux. Même parmi les 41, le tableau n° 90 conserve un seuil de VEMS. Le texte général

et ces tableaux peuvent donc être lus en sens contraire. De plus, le décret n° 2026-901 ne touche que les tableaux du code de la sécurité sociale, alors que le décret n° 2026-900 vise aussi les assurés agricoles, dont les tableaux relèvent du code rural.

Que devient un patient dont le dossier est bloqué ? Les règles valent pour les certificats établis à compter du 30 septembre 2026. Rien dans les textes lus n'indique si un patient au dossier antérieur peut déposer un nouveau certificat.

L'IMPACT FINANCIER & ORGANISATIONNEL

Pour le patient, l'attente d'une IRM ou d'une électroneuromyographie ne devrait plus bloquer à elle seule un dossier de tableau n° 57, mais seulement si la pathologie peut être caractérisée autrement. Pour le cabinet, la preuve change de place. L'Assurance Maladie retient comme 1re constatation la date où un médecin a constaté les symptômes pour la 1re fois, y compris dans un « compte rendu de consultation », même si le diagnostic est venu plus tard. Quand aucun examen daté n'est plus exigé, la note la plus ancienne du dossier du généraliste peut décider du sort de la demande : il faut la rechercher avant de rédiger le certificat.

Le décret n'efface pas les litiges. La caisse peut toujours réclamer des examens complémentaires, et un médecin qui se fie à la liste de l'Assurance Maladie peut continuer à prescrire ce que le tableau n'exige plus. L'enjeu est aussi financier : tant que la caisse n'a pas reconnu la maladie, elle verse les indemnités journalières au titre de l'assurance maladie, puis régularise en cas de reconnaissance, selon l'Assurance Maladie.

LE REGARD DU CERCLE

La mesure va dans le bon sens. Un droit à réparation ne devrait pas dépendre du délai pour obtenir une IRM, surtout dans les territoires où l'accès aux examens est le plus difficile.

Mais l'Assurance Maladie tire dans 2 sens. Le décret facilite la reconnaissance des maladies professionnelles ; la campagne de mise sous objectifs compte les arrêts liés au travail comme les autres, et dès le 1er jour, selon MG France. Un dossier complet déposé le 10 novembre 2026 peut rester à l'instruction jusqu'au 10 mars 2027, ou jusqu'au 8 juillet 2027 avec un comité régional, selon notre calcul. C'est en pleine période de mise sous objectifs, de janvier à juin 2027 selon la CSMF : pendant ce temps, les arrêts de ce patient pèsent sur l'indicateur de son médecin, reconnaissance ou non.

Le décret déplace aussi la preuve vers le cabinet. Sans examen exigé, le certificat et la note la plus ancienne du dossier du généraliste pèsent davantage, alors que la caisse peut toujours réclamer un examen « nécessaire », sans liste. Les décrets ont paru la veille de leur entrée en vigueur, la FMF n'a vu passer aucune communication de l'Uncam ni du ministère, et la liste d'examens de l'Assurance Maladie indique encore l'IRM pour le tableau n° 57. Le Cercle demande à l'Assurance Maladie de publier, tableau par tableau, ce que la caisse pourra encore demander et sur quelle recommandation, et de garantir qu'un dossier ne sera pas rejeté faute d'un examen que personne n'a demandé.

RECOMMANDATIONS

- **Médecin qui rédige un certificat médical initial de maladie professionnelle** : Rédiger ce certificat dès que la pathologie est susceptible d'être d'origine professionnelle, sans attendre un examen, et y inscrire la date de 1re constatation médicale avec les éléments qui la justifient, comme le demande l'Assurance Maladie.
- **Médecin dont le patient attend un examen réclamé par la caisse** : Demander par écrit à la caisse sur quelle recommandation elle maintient cet examen pour un certificat établi à compter du 30 septembre 2026, sans le différer, et faire noter au patient les dates de dépôt du dossier et de remise du résultat au médecin-conseil, les 120 jours pouvant ne courir qu'à partir de cette 2e date.

Sources

Décret n° 2026-900 du 24 septembre 2026 relatif aux modalités générales d'établissement du diagnostic des maladies prévues dans les tableaux de maladies professionnelles

Décret n° 2026-901 du 24 septembre 2026 relatif aux modalités d'établissement du diagnostic des maladies prévues dans les tableaux de maladies professionnelles annexés au livre IV du code de la sécurité sociale

Loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2026, article 95

Assurance Maladie, Maladie professionnelle (2 novembre 2026)

MG France, Ciblage MSO : analyse de la méthode (2 novembre 2026)

CSMF, Dites NON à la MSO ! (mise à jour le 9 novembre 2026)

FMF, Nouvelles modalités pour les maladies professionnelles (1er novembre 2026)

Traçabilité : décrets n° 2026-900 et n° 2026-901 du 24 septembre 2026, Journal officiel n° 227 du 29 septembre 2026, textes n° 3 et n° 4, lus en entier ; loi n° 2025-1403, article 95, II (le texte du I, qui modifie l'article L. 461-1, n'a pas pu être lu) ; Assurance Maladie, page du 2 novembre 2026 et liste d'examens téléchargée le 9 novembre 2026 et relue le 10 novembre 2026. La FMF, MG France et la CSMF sont citées comme acteurs.